

Информационное обеспечение скрининга

Абдикаримов А.М., Мустафина Б.К.

ГККП «Городской онкологический диспансер», г.Астана

Введение

Среди разнообразных заболеваний молочной железы у женщин рак (РМЖ) представляет важнейшую проблему из-за высокой заболеваемости и смертности от него. В последние годы РМЖ прочно занимает первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных заболеваний женского населения Казахстана. Выявляемость заболевания на профосмотрах в целом по стране остается низкой, а показатель запущенности (III-IV стадии), который является критерием качества диагностики, напротив, высоким - около 40%.

Цель исследования

Улучшить показатели скрининга РМЖ, путем укрепления сознания граждан, через средства массовой информации.

Материалы и методы исследования. Как известно, снижение смертности от рака молочной железы и успехи в лечении во многом определяются ранней диагностикой заболевания: при I стадии 5-летний срок переживают 90-95% больных; при IV – менее 10% [1]. Однако, большинство заболевших сами обнаруживали у себя опухоль; выявленные таким путем новообразования, к сожалению, не соответствовали ранним стадиям процесса. Очевидно, что для улучшения результатов диагностики и лечения скринингу (массовому обследованию здорового населения) нет альтернативы. Так, до 1980-х гг. рост заболеваемости и смертности от рака молочной железы наблюдался как в развивающихся, так и в экономически развитых странах. Затем, по мере внедрения маммографического скрининга, улучшения результатов диагностики и лечения, в экономически развитых странах Западной Европы, произошло замедление, а затем и снижение смертности, в то время как в странах Восточной Европы и Латинской Америки, напротив, смертность от рака молочной железы продолжала возрастать. В странах Западной Европы и Северной Америки достигнута возможность выявления I стадии заболевания у 70-80% и, соответственно, выздоровления от рака молочной железы 60-80% женщин [7,8]. Маммографический скрининг, таким образом, позволил уменьшить смертность от рака молочной железы на 30% через 5-7 и на 20% через 15-20 лет от начала скрининга [2].

Учитывая это, основным направлением маммологии, по-прежнему, является поиск путей раннего выявления рака и предопухолевых заболеваний молочной железы. Проведение маммографического скрининга предполагает решение многих организационных задач. Кроме обеспечения финансирования, необходимо добиться активного и добровольного участия в скрининге самих женщин. Следует отметить существенные различия в психологии обследуемых в странах Западной Европы и Северной Америки, сравнительно с «установками» пациенток в Казахстане. В отличие от рационального, прагматичного отношения к своему здоровью на Западе, наш контингент обследуемых часто не уделяет должного внимания состоянию здоровья, не осознает важности, значимости своевременной диагностики и лечения (в том числе – и по стоимости затрат на обеспечение здоровья). Так, анализируя результаты прошлых лет, оказалось что в г.Астана в 2008 году по программе скрининга осмотрено 10902 женщин

Проведен анализ предпосылок для применения скрининга в клинической онкологии. Определены основные проблемы скрининга и рассмотрены подходы к устранению некоторых из них. Продемонстрирована возможность улучшения показателей выявляемости путем укрепления сознания граждан через средства массовой информации. Подчеркнута роль журналистов, психологов, социологов, непосредственное участие которых необходимо для максимального качества скрининга. Выделено понятие «информационное обеспечение» как раздел в комплексе скрининговых мероприятий.

Скринингтің мәліметімен қамтамасыз ету

А.М. Абдикаримов, Б.К. Мустафина

ММҚК «Қалалық онкология диспансері», Астана қ.

Қорытынды: Клиникалық онкологиядағы скринингтің қолдануы үшін алғышарттардың талдауы жүргізілген. Скринингтің негізгі мәселелері анықталған және кейбіреулерді жоюға жолдар қаралған. Табылудың көрсеткіштерінің жақсартуы бұқаралық ақпарат құралдан азаматтардың сананың күшейтуі мүмкіндік жолымен көрсеткен. Журналистердің, психологтердің, социологтердің рөлі көрсетілген және олардың қатысуы скринингтің максимал сапасы үшін керек. «Мәліметпен қамтамасыз ету» ұғым скрининг шараларының кешеніндегі бөлім ретінде ерекшеленген.

Information Support Of Screening

A.M.Abdikarimov, B.K. Mustafina.

SCCE "City oncology hospital", Astana.

Summary: The analysis of the preconditions for the application of screening in clinical oncology was conducted. The main problems of screening and approaches to address some of them was determined. The possibility of improvement in detection by enhancing the consciousness of the citizens through the media is demonstrated. The role of journalists, psychologists, sociologists, direct participation is required to maximize the quality of screening. "Information management" is highlighted as a part of complex screening activities.

и выявлено 18 случаев злокачественных новообразований молочной железы, что составило 0,17%, а в 2009 году осмотрено уже 10161 и выявлено 11 случаев рака молочной железы (0,10%). При этом всего впервые установлен диагноз РМЖ в 2008 и 2009 годах у 177 и 171 женщин соответственно. Из них с первой и второй стадией заболевания выявлено всего лишь 114 (64,4%)-2008г и 119 (69,9%)- в 2009 годах. Тогда возникает вполне разумный вопрос: «В чем же причина? Почему, при таком широком охвате населения РМЖ обнаружен в основном вне программы?»

Проблемой являются мотивы, которые заставляют «асимптоматическое» население принимать участие в скрининге. Рассчитанный биологический цикл развития

большинства злокачественных новообразований длится 8-15 лет [3,4]. Вопрос о том, какие именно предпосылки должен заставить человека, считающего себя практически здоровым, проходить регулярное обследование для исключения (или подтверждения?) наличия рака, практически не изучено. Проводимые по этому вопросу сведения имеют несистематизированный характер. Но, например, от участия в бесплатном скрининге отказываются от одной трети до 79% женщин [5,6]. Таким образом, возникает следующая проблема- информирование населения о проведении скрининга. Казалось бы, этот вопрос прямо не входит в задачи клинической онкологии. Однако любые материальные затраты на организацию скрининга могут оказаться бессмысленными при отсутствии у населения стимулов к участию в скрининге. При построении стратегии информационного обеспечения скрининга необходимо учитывать: доступность средств массовой информации для населения, интеллектуальный уровень потребителей информации, социальные стереотипы проведения в отношении представляемой проблемы, культурные, религиозные и этнические традиции, кратность и объем поступления информации, форму и стиль изложения. В отличие от научно- исследовательских моделей скрининга проведение рутинного скрининга должно предусматривать вариабельность и нестабильность контингентов входящих и выходящих из системы скрининга. Необходимо учитывать еще один критерий скрининга - безопасность. Форма подачи материалов не должна провоцировать потребителей на необдуманные и опасные действия- отказ от посещения врача, или, тем более, на суицид. Следует учитывать также и то, что часть населения, с уже установленным диагнозом, может воспользоваться системой скрининга для «проверки» правильности диагноза.

Результаты исследования

Важнейшая мотивация активного и добровольного участия в профилактических обследованиях – сохранение собственной жизни и здоровья – не укрепляется в сознании граждан средствами массовой информации (телевидение, радио, пресса). Для максимального качества информационного обеспечения необходима стабильная многолетняя работа ряда специалистов- журналистов, психологов, социологов, имеющих соответствующее образование и владеющих перечисленными формами работы. Таким образом, информационное обеспечение скрининга является одним из важных разделов в комплексе скрининговых мероприятий.

Список использованной литературы

1. Ганцев Ш.Х. Онкология (учебник для медицинских вузов). 2-е издание- Москва: МИА 2006, 255с.
2. Семиглазов, В.В., Семиглазов, В.Ф. Клинико-морфологические особенности и методы лечения неинвазивного рака молочной железы /Вопросы онкологии.- 2001.-Т.47,- №3.- С.278-287.
3. Стариков В.И. Общая онкология.- Харьков, 2000.- 120 с.
4. Дильман В.М. Эндокринологическая онкология (руководство для врачей). 2-е издание- Москва: Медицина 1983, 211с.
5. Левшин В.Ф., Федичкина Т.П., Дрожжачих В.Г. и др. Исследование возможностей внедрения и эффективности различных видов маммографического скрининга.- Маммология 1997;(4): 25-31.
6. Eddy D.M., Yasselbled V., McGiveney W., Hendee W. The value of mammography screening in women under age 50 years. JAMA 1988; (11): 1512-9.
7. Hopper J.L., Chenevix-Trench G., Jolley D.J. et al. // J. Cancer Natl. Inst. — 1999. — N 26. — P. 95—100.
8. Kelsey J.L., Gammon M.D. // A cancer journal for clinicians. — 1991. — V. 41, N 3. — P. 146—165.